

Objetivos Terapéuticos: Cómo Trabajarlos con el Paciente

Formulación, revisión y manejo de la incertidumbre Fundamento en TCC, ACT, DBT y Entrevista Motivacional

Los objetivos terapéuticos no son un trámite administrativo — son el corazón del proceso. En psicología basada en evidencia, los objetivos cumplen tres funciones fundamentales: orientan las intervenciones, proveen criterios de evaluación del progreso y potencian la alianza terapéutica al darle al paciente un rol activo en su propio cambio (Tryon & Winograd, 2011; Norcross, 2011).

La alianza terapéutica y los objetivos

El meta-análisis de Tryon & Winograd (2011) sobre más de 15.000 pacientes mostró que el acuerdo en metas y tareas terapéuticas — componente central de la alianza según Bordin (1979) — es uno de los predictores más robustos del resultado terapéutico, independientemente del modelo teórico.

1. Marco Teórico: ¿Por qué los objetivos importan?

■ Terapia Cognitivo-Conductual (Beck, 1979)

Los objetivos en TCC son colaborativos y explícitos. Se formulan en términos conductuales y cognitivos observables, lo que permite evaluar el cambio de manera concreta. Beck planteó la agenda como herramienta para mantener el foco y los objetivos como brújula del tratamiento.

■ Terapia de Aceptación y Compromiso — ACT (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012)

ACT propone que los objetivos terapéuticos estén anclados en los valores del paciente. No se trabajan síntomas sino dirección vital: ¿hacia qué quiere moverse esta persona? Los objetivos son movimiento hacia lo significativo, no simplemente reducción del malestar.

■ Terapia Dialéctico-Conductual — DBT (Linehan, 1993)

DBT establece una jerarquía explícita de objetivos: primero conductas que amenazan la vida, luego conductas que interfieren con la terapia, luego calidad de vida. Esta jerarquía orienta al terapeuta sobre qué priorizar en cada momento del tratamiento.

■ Entrevista Motivacional (Miller & Rollnick, 2002)

EM plantea que los objetivos deben emerger de la motivación intrínseca del paciente. Cuando el terapeuta impone objetivos sin explorar la ambivalencia, genera reactancia. La co-construcción aumenta el compromiso con el cambio.

■ Bordin, E.S. (1979). *The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance*. *Psychotherapy*, 16(3), 252-260.

2. Cómo Formular Objetivos: Proceso Práctico

La formulación de objetivos es un proceso clínico, no una checklist. Requiere escucha activa, reformulación colaborativa y sensibilidad al momento del proceso terapéutico.

1	Escuchar sin reformular todavía En las primeras sesiones, el objetivo es comprender el problema desde el marco del paciente. Reformular prematuramente puede generar que el paciente sienta que "no lo entendieron".
2	Explorar la dirección deseada Preguntas desde ACT: "¿Qué es importante para vos que cambie?", "Si este problema no existiera, ¿qué estarías haciendo diferente?". Esto conecta con valores, no solo con síntomas.
3	Traducir a objetivos concretos El lenguaje vago no orienta el tratamiento. Trabajá junto al paciente para hacer los objetivos específicos y observables. Ver tabla de traducción a continuación.
4	Verificar el compromiso Desde EM: "En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es para vos trabajar esto?". Si la motivación es baja, ese es el primer objetivo a trabajar.
5	Documentar y compartir El paciente puede tener una copia de sus objetivos. La transparencia fortalece la alianza y le da herramientas para monitorear su propio progreso.

De lenguaje vago a objetivos concretos:

LO QUE DICE EL PACIENTE	OBJETIVO REFORMULADO	FOCO CLÍNICO
"Quiero estar mejor"	Reducir frecuencia e intensidad de episodios de tristeza; retomar actividades evitadas	Activación conductual (TCC)
"Quiero ser más seguro"	Desarrollar habilidades de autoafirmación; reducir conductas de evitación social	Exposición + asertividad
"No quiero sentir ansiedad"	Aprender a tolerar la ansiedad sin evitarla; reducir su impacto funcional	Defusión cognitiva (ACT)
"Quiero que mi relación funcione"	Identificar patrones relacionales disfuncionales; desarrollar comunicación efectiva	DEAR MAN (DBT)

"No sé qué me pasa"	Identificar y comprender los propios estados emocionales y sus desencadenantes	Psicoeducación emocional
---------------------	--	--------------------------

3. Revisión de Objetivos en el Proceso Terapéutico

Lambert et al. (2001) demostraron que el monitoreo sistemático del progreso, cuando se comparte con el paciente, mejora los resultados y reduce el abandono. La revisión no es un acto administrativo: es una intervención terapéutica en sí misma.

MOMENTO	QUÉ HACÉS	CÓMO LO MEDÍS
Cada 4-6 semanas	Check-in breve sobre percepción del progreso	Escala subjetiva 1-10 del paciente
Cada 8-12 semanas	Revisión formal de objetivos: ¿siguen siendo relevantes?	PHQ-9, GAD-7, BDI o equivalente
Ante estancamiento	Reformulación del caso: ¿estamos trabajando el problema correcto?	Análisis funcional + supervisión
Al cierre	Evaluación de logros, consolidación y prevención de recaídas	Comparación pre-post + plan de mantenimiento

■ Lambert, M.J. et al. (2001). *The effects of providing therapists with feedback on patient progress. Psychotherapy Research, 11(1), 49-68.*

4. Cuando el Paciente No Sabe Qué Quiere

La incertidumbre sobre los propios objetivos es clínicamente significativa. Puede indicar confusión emocional, alexitimia, baja autoeficacia percibida, o que el paciente está en una etapa de precontemplación según el modelo transteórico de Prochaska & DiClemente (1983). En ningún caso debe interpretarse como "resistencia" ni como obstáculo para comenzar.

■ El proceso de descubrir qué se quiere es un objetivo válido

Formulalo explícitamente: "Uno de nuestros primeros objetivos es entender qué querés cambiar y en qué dirección querés moverte." Esto reduce la ansiedad del paciente y da sentido a las primeras sesiones.

■ Trabajar desde los valores (ACT)

Cuando no hay claridad sobre objetivos, los valores son una puerta de entrada más accesible. Ejercicio: pedile al paciente que imagine que tiene 90 años y mira su vida. ¿Qué querría haber hecho? ¿Qué tipo de persona querría haber sido? Desde ahí emergen los objetivos.

■ Usar escalas de satisfacción vital

La "Rueda de la Vida" o el cuestionario de satisfacción en áreas (salud, vínculos, trabajo, ocio, desarrollo personal) permiten identificar qué áreas generan más malestar sin que el paciente tenga que articular objetivos en abstracto.

■ Evaluar la etapa motivacional (Prochaska & DiClemente)

Si el paciente está en precontemplación o contemplación, el objetivo inicial no es el cambio sino aumentar la conciencia del problema y la motivación. Aplicar técnicas de cambio sin motivación produce abandono temprano.

■ *Nota clínica: No fuerces la claridad donde no la hay. Un paciente que no sabe qué quiere necesita ser acompañado en ese proceso, no apurado. Forzar objetivos prematuros puede generar que el paciente se adapte a lo que cree que el terapeuta quiere escuchar.*

■ Prochaska, J.O. & DiClemente, C.C. (1983). *Stages and processes of self-change of smoking. Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390-395.

■ Hayes, S.C., Strosahl, K. & Wilson, K.G. (2012). *Acceptance and Commitment Therapy (2nd ed.)*. Guilford Press.

"La terapia no es hacerle al paciente lo que el terapeuta cree que necesita. Es acompañar al paciente a descubrir lo que él mismo quiere y puede."

— Adaptado de Linehan, M.M. (1993). *Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder*.

© quieroterapia.com.ar | Recurso clínico de uso exclusivo para miembros de la plataforma | Basado en evidencia científica